医原性血胸を契機として診断された後天性血友病 A の 1 症例

◎松尾 そら[1)]、大嶋 剛史[1)]、伊藤 英史[1)]、佐藤 彩[1)]、藤原 妙[1)]、糠野 珠里[1)]
医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院[1)]

【はじめに】後天性血友病 A(acquired hemophilia A:AHA)とは、後天的に凝固第 VIII 因子に対する自己抗体ができることで重篤な出血症状をきたす疾患である。本症の発症率は人口 100 万人当たり年間約 1.5 人であり、稀な疾患と認識されているが、近年増加傾向にある。今回、医原性血胸を契機として後天性血友病 A と診断された症例を経験したので報告する。

【症例】50 代女性。既往歴：虫垂炎、高血圧症。前医にて細菌性胸膜炎が疑われ、胸腔穿刺が行われた。その後、肋間動静脈損傷および胸腔内出血による出血性ショックが疑われ、当院に転院搬送・開胸血腫除去術が行われた。

【来院時検査所見】WBC 17.5×10^3/μL、RBC 3.50×10^6/μL、Hb 10.4g/dL、Ht 29.4%、PLT 127×10^3/μL、PT 14.6 秒、APTT 56.2 秒、FIB 340mg/dL

【経過】術後も APTT 延長を認めたため、精査として各種検査が実施された。クロスミキシング試験はインヒビターパターンであった。第 VIII 因子インヒビターは 2 BU/mL であり、第 VIII 因子活性が４％と低値であったため、後天性血友病 A と診断された。ステロイド治療が開始され、APTT は著明に改善し（表１）、第 VIII 因子インヒビターは陰性化、第 VIII 因子活性も次第に正常化し、退院となった。

表１　APTT（秒）の推移

0 病日目（転院当日）	2 病日目	14 病日目	19 病日目（治療開始 5 日）	34 病日目（治療開始 20 日）
56.2	74.2	102.5	71.0	38.8

【まとめ】AHA は死亡率が約 25%と高く、早期診断・治療が重要である。本症例は、APTT 過延長に対し、血友病 A・B、抗リン脂質抗体症候群、大量出血後の希釈性凝固障害など様々な病態の可能性が考慮され、速やかに検査が実施されたことが早期診断に繋がった。今回の経験を通じて、APTT 延長症例に遭遇した際には、AHA を含めた幅広い鑑別を念頭に置き、必要に応じて追加検査を提案するなど、診療に寄与していきたい。

連絡先：0566-25-2948